

**Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia**

**Mestrado Integrado em Medicina Veterinária**

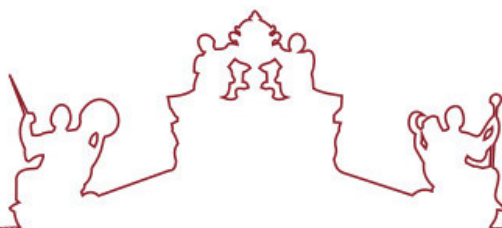
Relatório de Estágio

**Doença do Trato Urinário Inferior em Felinos: Revisão  
Bibliográfica e Relato de um Caso Clínico de Obstrução  
Uretral**

**Júlia Aidos Leal**

Orientador(es) | Catarina Lavrador  
karla cardoso  
Andrea Amatulli

Évora 2026



**Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia**

**Mestrado Integrado em Medicina Veterinária**

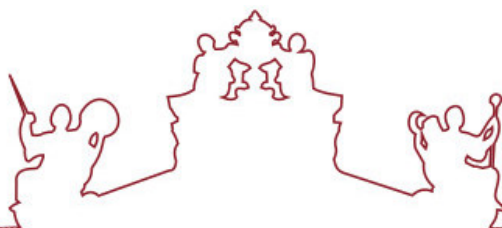
Relatório de Estágio

**Doença do Trato Urinário Inferior em Felinos: Revisão  
Bibliográfica e Relato de um Caso Clínico de Obstrução  
Uretral**

**Júlia Aidos Leal**

Orientador(es) | Catarina Lavrador  
karla cardoso  
Andrea Amatulli

Évora 2026



O relatório de estágio foi objeto de apreciação e discussão pública pelo seguinte júri nomeado pelo Diretor da Escola de Ciências e Tecnologia:

Presidente | Nuno Miguel Lourenço Alexandre (Universidade de Évora)

Vogais | Catarina Lavrador (Universidade de Évora) (Orientador)  
Maria Teresa Oliveira (Universidade de Évora) (Arguente)

PREVIEW



## **I. Dedicatórias**

Dedico este relatório de estágio

Aos meus pais, Marco Antonio e Rosália, por todo o amor incondicional, por acreditarem em mim nos momentos difíceis e por me permitirem sonhar e concretizar.

À minha irmã, Fernanda, pela força que sempre me transmitiu, lembrando-me diariamente da resiliência que habita em mim.

Ao meu irmão, Pedro, pela leveza e pelos conselhos que trouxeram alívio aos dias mais desafiadores.

À Ana Aubrey e ao Gabriel, que, mesmo não sendo família de sangue, tornaram-se parte da minha família, com carinho, apoio e presença constantes.

E ao Martim, meu primeiro sobrinho – o amor da minha vida – por me lembrar todos os dias o que é amor puro e genuíno.

Aos meus companheiros de quatro patas – Kira e Fred, Snoopy e Caco – e à eterna memória da Perla, Lila, Nico e Toby, que me inspiram a ser uma médica veterinária melhor a cada dia.

Aos que partiram – o meu avô Manuel, o avô Alcibíades, a avó Anair e a avó Eulídia – expresso a minha eterna gratidão e amor.

## **II. Agradecimentos**

Agradeço à minha orientadora, Dra. Catarina, pela disponibilidade, paciência e orientação ao longo de todo este processo.

À minha coorientadora, Dra. Karla, pelo apoio, incentivo e confiança depositados durante estes anos de aprendizagem.

Aos amigos espalhados pelo Brasil, Portugal e pelo mundo, obrigada pela amizade, carinho e pelas risadas que atravessaram distâncias e tornaram o caminho mais leve. Um agradecimento especial à Elisa e à Lisa, pela presença constante e apoio em todas as fases desta jornada.

Aos colegas de faculdade e de trabalho, pela partilha de experiências e suporte nos momentos mais desafiadores.

À Comunidad Inti Wara Yassi, ao Projeto Tamar de Florianópolis, ao CETAS de Santa Catarina pela oportunidade de conhecer o trabalho com a vida selvagem e por continuarem a inspirar-me diariamente na nobre missão de reabilitar e devolver à natureza a fauna silvestre, costeira e marinha.

### III. Resumo

O presente relatório de estágio aborda a Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos , uma condição clínica comum em medicina felina, caracterizada por sinais clínicos como disúria, estrangúria, hematúria e, por vezes, obstrução uretral. Trata-se de uma condição de etiologia multifatorial, frequentemente recorrente, que representa um desafio clínico pela diversidade de causas envolvidas e pelo impacto no bem-estar animal.

A primeira parte do presente trabalho consiste num relatório que integra a análise casuística acompanhada durante o estágio curricular no Ticino Animal Hospital, na Suíça. A segunda parte corresponde a uma revisão bibliográfica atualizada sobre as principais causas de sinais do trato urinário inferior em felinos. Por fim, a terceira parte apresenta um caso clínico representativo de obstrução uretral, acompanhado e documentado durante o referido estágio.

O caso clínico descrito ilustra a complexidade do manejo dos gatos com sinais do trato urinário inferior, realçando a importância de uma abordagem individualizada, que considere fatores ambientais, comportamentais e clínicos.

**Palavras-Chave:** *trato urinário inferior, cistite idiopática felina, urolitíase, obstrução uretral, infecção*

## IV. Abstract

### Literature Review and Clinical Case Report of Urethral Obstruction

This internship report addresses Feline Lower Urinary Tract Disease, a common clinical condition in feline medicine, characterised by signs such as dysuria, stranguria, haematuria, and, in some cases, urethral obstruction. It is a multifactorial and often recurrent condition that poses a clinical challenge due to the variety of underlying causes and its impact on animal welfare.

This internship report is divided into three parts: a case analysis based on clinical experience during a curricular internship at the Ticino Animal Hospital in Switzerland; an updated literature review on the main causes of lower urinary tract signs in cats; and the presentation of a representative clinical case of urethral obstruction.

The clinical case described illustrates the complexity of managing cats with lower urinary tract signs and highlights the importance of an individualised approach that considers clinical, environmental, and behavioural factors.

**Keywords:** *lower urinary tract, feline idiopathic cystitis, urolithiasis, urethral obstruction, infection*

## V. Sumário

|              |                                                           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>I.</b>    | <b>DEDICATÓRIAS</b>                                       | <b>I</b>    |
| <b>II.</b>   | <b>AGRADECIMENTOS</b>                                     | <b>II</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>RESUMO</b>                                             | <b>III</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>ABSTRACT</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>VI.</b>   | <b>ÍNDICE DE TABELAS</b>                                  | <b>VI</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>ÍNDICE DE GRÁFICOS</b>                                 | <b>VII</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>ÍNDICE DE FIGURAS</b>                                  | <b>VII</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>ÍNDICE DE ANEXOS</b>                                   | <b>VIII</b> |
| <b>X.</b>    | <b>LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS</b>                     | <b>IX</b>   |
| <b>I.</b>    | <b>INTRODUÇÃO</b>                                         | <b>1</b>    |
| 1.           | TICINO ANIMAL HOSPITAL                                    | 1           |
| 2.           | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO                | 2           |
| 3.           | ESTRUTURA DO RELATÓRIO                                    | 3           |
| <b>II.</b>   | <b>ANÁLISE DA CASUÍSTICA OBSERVADA</b>                    | <b>4</b>    |
| 1.           | DISTRIBUIÇÃO CASUÍSTICA POR ESPÉCIE ANIMAL E ÁREA CLÍNICA | 4           |
| 2.           | DISTRIBUIÇÃO CASUÍSTICA DA CLÍNICA MÉDICA                 | 5           |
| 3.           | DISTRIBUIÇÃO CASUÍSTICA DA CLÍNICA CIRÚRGICA              | 25          |
| 4.           | DISTRIBUIÇÃO CASUÍSTICA DA MEDICINA PREVENTIVA            | 30          |
| 5.           | AQUISIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS                  | 31          |
| <b>III.</b>  | <b>DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR DOS FELINOS</b>      | <b>31</b>   |
| 1.           | ANATOMIA E FISIOLOGIA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR FELINO   | 31          |
| 2.           | CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A DTUIF                        | 35          |
| 2.5.         | TERAPÊUTICA MÉDICA GERAL                                  | 42          |
| 3.           | ETIOLOGIAS DAS SÍNDROMES DO TRATO URINÁRIO INFERIOR       | 46          |
| 3.1.         | CISTITE IDIOPÁTICA FELINA                                 | 47          |
| 3.2.         | UROLITÍASE                                                | 52          |
| 3.3.         | INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO                                | 57          |
| 3.4.         | OBSTRUÇÃO URETRAL                                         | 63          |
| 3.5.         | OUTRAS DOENÇAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR DOS FELINOS     | 72          |
| 4.           | CASO CLÍNICO                                              | 73          |
| 5.           | DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICA                               | 77          |
| 6.           | CONCLUSÃO                                                 | 81          |
|              |                                                           | <b>V</b>    |

## **VI. Índice de tabelas**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Distribuição da casuística pelas diferentes áreas clínicas .....                          | 5  |
| Tabela 2 – Distribuição da casuística pelas diferentes áreas da clínica médica .....                 | 6  |
| Tabela 3 – Distribuição da casuística referente à área de Gastroenterologia e Glândulas Anexas ..... | 8  |
| Tabela 4 – Distribuição da casuística referente à área de Oftalmologia.....                          | 9  |
| Tabela 5 - Distribuição da casuística referente à área de Urologia e Nefrologia .....                | 10 |
| Tabela 6 - Distribuição da casuística referente à área de Medicina de Emergência.....                | 11 |
| Tabela 7 - Distribuição da casuística referente à área de Oncologia .....                            | 12 |
| Tabela 8 - Distribuição da casuística referente à área de Ortopedia e Traumatologia....              | 13 |
| Tabela 9 - Distribuição da casuística referente à área de Estomatologia.....                         | 15 |
| Tabela 10 - Distribuição da casuística referente à área de Dermatologia.....                         | 15 |
| Tabela 11 - Distribuição da casuística referente à área de Cardiologia .....                         | 16 |
| Tabela 12 - Distribuição da casuística referente à área de Pneumologia.....                          | 17 |
| Tabela 13- Distribuição da casuística referente à área de Toxicologia.....                           | 19 |
| Tabela 14 - Distribuição da casuística referente à área de Neurologia.....                           | 20 |
| Tabela 15 - Distribuição da casuística referente à área de Doenças Infeciosas.....                   | 20 |
| Tabela 16 - Distribuição da casuística referente à área de Endocrinologia .....                      | 21 |
| Tabela 17 - Distribuição da casuística referente à área de Hematologia e Imunoalergologia .....      | 22 |
| Tabela 18 - Distribuição da casuística referente à área de Doenças Parasitárias .....                | 23 |
| Tabela 19 - Distribuição da casuística referente à área de Reprodução, Ginecologia e Andrologia..... | 24 |
| Tabela 20 - Distribuição da casuística referente à área de Clínica Cirúrgica .....                   | 25 |
| Tabela 21 - Distribuição da casuística referente à área de Cirurgia de Tecidos Moles ..              | 26 |
| Tabela 22 - Distribuição da casuística referente à área de Cirurgia Odontológica.....                | 28 |
| Tabela 23- Distribuição da casuística referente à área de Cirurgia Ortopédica.....                   | 29 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 24 - Classificação das infeções do trato urinário complicadas após tratamento antimicrobiano..... | 58 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **VII. Índice de gráficos**

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Gráfico 1 – Frequência relativa da casuística consoante a espécie ..... | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|

## **VIII. Índice de figuras**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Instalações do Ticino Animal Hospital .....                                               | 2  |
| Figura 2 – Exemplos de agentes parasitários observados em cães.....                                  | 24 |
| Figura 3 – Exemplos de procedimentos cirúrgicos e neonatais em cães.....                             | 28 |
| Figura 4 – Anatomia da bexiga urinária felina .....                                                  | 32 |
| Figura 5 – Anatomia do trato urinário inferior felino masculino .....                                | 33 |
| Figura 6 – Material utilizado na urianálise de rotina em felinos .....                               | 39 |
| Figura 7 – Bexiga distendida por obstrução uretral.....                                              | 65 |
| Figura 8 – ECG de gato com taquicardia ventricular em gato com obstrução uretral e hipercalemia..... | 65 |
| Figura 9 – Projeções radiográficas do abdómen.....                                                   | 74 |
| Figura 10 – Cistocentese ecoguiada realizada no paciente.....                                        | 76 |
| Figura 11 – Cristais de estruvite observados em amostra de urina do paciente .....                   | 77 |

## **IX. Índice de anexos**

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 1 – Hemograma do paciente, realizado no dia 08.01.2025 .....                    | 97  |
| Anexo 2 – Pannel bioquímico do paciente, realizado no dia 08.01.2025 .....            | 98  |
| Anexo 3 – Hemogasometria e ionograma do paciente, realizados no dia 08.01.2025 ...    | 99  |
| Anexo 4 – Resultado da cultura urinária do paciente, realizado no dia 09.01.2025 .... | 100 |
| Anexo 5 – Ecografia abdominal do paciente, realizado no dia 08.01.2025 .....          | 101 |
| Anexo 6 – Urianálise do paciente, realizado no dia 08.01.2025 .....                   | 102 |
| Anexo 7 – Pannel bioquímico do paciente, realizado no dia 08.01.2025 .....            | 103 |
| Anexo 8 – Pannel bioquímico do paciente, realizado no dia 15.01.2025 .....            | 104 |
| Anexo 9 – Ecografia abdominal do paciente, realizado no dia 21.01.2025 .....          | 105 |
| Anexo 10 – Urianálise do paciente, realizado no dia 29.01.2025 .....                  | 106 |

## **X. Lista de abreviaturas e siglas**

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>AFAST</b>  | Avaliação focada com ecografia para trauma abdominal                  |
| <b>AINE</b>   | Anti-inflamatórios não esteroides                                     |
| <b>BID</b>    | Em português duas vezes ao dia, do latim <i>bis in die</i>            |
| <b>CIF</b>    | Cistite idiopática felina                                             |
| <b>DTUIF</b>  | Doença do trato urinário inferior dos felinos                         |
| <b>DU</b>     | Débito urinário                                                       |
| <b>DEU</b>    | Densidade específica da urina                                         |
| <b>IM</b>     | Via intramuscular                                                     |
| <b>ISCAID</b> | Sociedade Internacional de Doenças Infeciosas em Animais de Companhia |
| <b>ISFM</b>   | Sociedade Internacional de Medicina Felina                            |
| <b>ITU</b>    | Infeção do trato urinário                                             |
| <b>IV</b>     | Via intravenosa                                                       |
| <b>LCA</b>    | Ligamento cruzado anterior                                            |
| <b>MEMO</b>   | Modificação multimodal do ambiente                                    |
| <b>OU</b>     | Obstrução uretral                                                     |
| <b>PO</b>     | Em português via oral, do latim <i>per os</i>                         |

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>RCPU</b>   | Relação creatinina:proteína urinária                       |
| <b>SC</b>     | Via subcutânea                                             |
| <b>SCRA</b>   | Sistema central de resposta à ameaça                       |
| <b>SID</b>    | Em português uma vez ao dia, do latim <i>semel in die</i>  |
| <b>SNC</b>    | Sistema nervoso central                                    |
| <b>STUI</b>   | Sinais do trato urinário inferior                          |
| <b>TAH</b>    | Ticino animal hospital                                     |
| <b>TC</b>     | Tomografia computadorizada                                 |
| <b>T-FAST</b> | Avaliação focada com ecografia para trauma torácico        |
| <b>TID</b>    | Em português três vezes ao dia, do latim <i>ter in die</i> |
| <b>THC</b>    | Tetrahydrocannabinol                                       |
| <b>TSA</b>    | Teste de sensibilidade a antimicrobianos                   |
| <b>TUI</b>    | Trato urinário inferior                                    |

## **I. Introdução**

O presente relatório de estágio foi elaborada no âmbito do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da Universidade de Évora, com o objetivo de descrever e analisar as atividades desenvolvidas durante os quatro meses de estágio curricular realizado no *Ticino Animal Hospital (TAH)*, localizado na região do Ticino, no sul da Suíça. O estágio decorreu sob a orientação interna da Professora Doutora Catarina Lavrador e da Mestre Karla Menezes Cardoso, contando ainda com a orientação externa do Médico Veterinário Andrea Amatulli.

### **1. Ticino Animal Hospital**

O TAH é um hospital veterinário dedicado exclusivamente a animais de companhia, fundado em 2018. O hospital dispõe de atendimento 24 horas, com consultas em diversas especialidades e serviços avançados de diagnóstico e internamento.

A sua infraestrutura inclui uma área de receção, quatro consultórios médicos, uma unidade de internamento composta por duas salas, sendo uma destinada exclusivamente a casos infecciosos —, uma sala de preparação cirúrgica, dois blocos operatórios (um para procedimentos limpos e outro para cirurgias contaminadas), um setor de imagiologia e um laboratório clínico próprio.

Entre as especialidades médicas oferecidas destacam-se a cardiologia, ortopedia, oncologia, dermatologia, oftalmologia, nutrição e homeopatia. No que respeita ao diagnóstico por imagem, são realizados exames como ecografia, radiografia digital, endoscopia e tomografia computadorizada (TC). O laboratório clínico interno permite a realização de análises hematológicas e bioquímicas, testes rápidos (SNAP), avaliação de biomarcadores e observação microscópica, assegurando um suporte diagnóstico eficaz e completo.

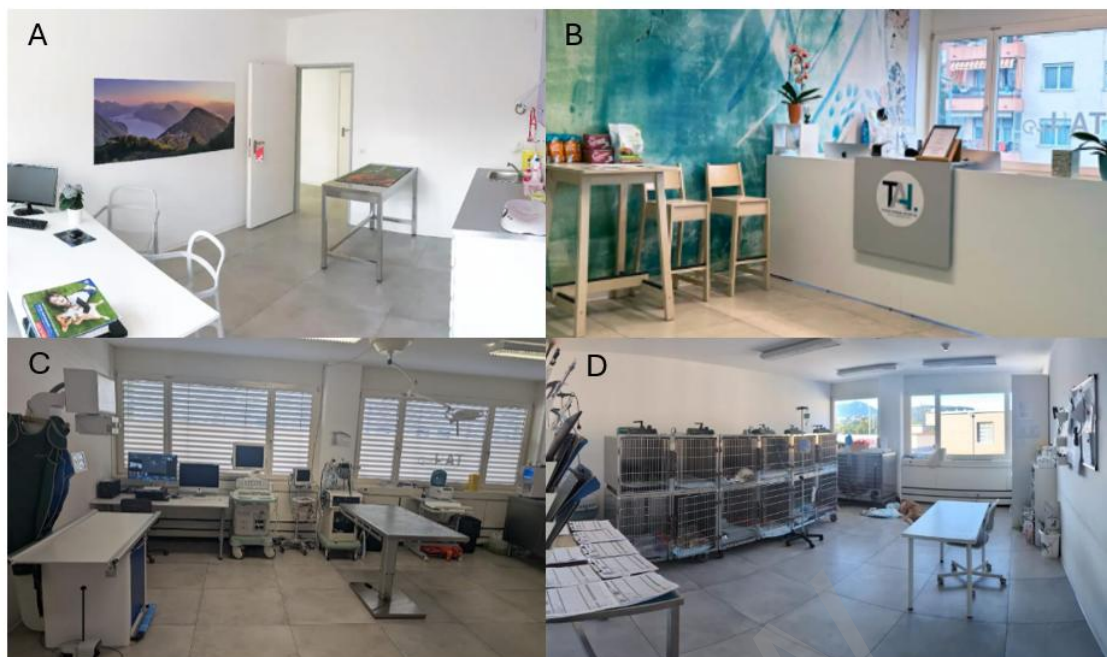


Figura 1 – Instalações do TAH. (A) Consultório e (B) recepção – imagens retiradas do site oficial do TAH; (C) setor de imagem e análises laboratoriais e (D) internamento. Imagens de M.V. Beatriz Patrony, autorizadas pelo TAH)

## 2. Atividades desenvolvidas durante o estágio

O estágio curricular decorreu entre 15 de outubro de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, totalizando 720 horas. Durante este período, foi possível participar ativamente nos diversos setores do hospital – internamento, urgências, cirurgias e consultas – através de um sistema rotativo com cerca de um mês por área, o que proporcionou uma visão diversificada da prática clínica veterinária de animais de companhia.

Na área de internamento, procedeu-se ao acompanhamento diário dos pacientes hospitalizados, incluindo o registo de parâmetros clínicos, administração de medicamentos e realização de procedimentos como colocação de cateteres venosos, algaliação, sondagem nasogástrica e colheitas sanguíneas. Além disso, as passagens de turno ocorriam três vezes por dia, permitindo uma monitorização constante da evolução dos casos.

Durante o período no serviço de urgências, foi possível desenvolver competências em situações críticas, participando em procedimentos como toracocentese, desobstrução

uretral e reanimação cardiopulmonar. Esta área foi exigente e formativa, destacando a importância da rapidez, precisão e trabalho em equipa na tomada de decisões clínicas.

A passagem pela área cirúrgica possibilitou a colaboração direta com os médicos cirurgiões e anestesistas, com envolvimento na preparação dos pacientes, monitorização anestésica intraoperatória e cuidados pós-operatórios.

Nas consultas clínicas gerais e especializadas, foi possível assistir e auxiliar os médicos veterinários em atividades como anamnese, exame físico e realização de exames complementares, como ecografias e análises laboratoriais. Esta experiência reforçou a importância do raciocínio clínico, da utilização criteriosa dos meios complementares de diagnóstico, assim como da capacidade de transmitir informações de forma clara e acessível aos tutores.

De forma geral, o estágio no TAH constituiu uma experiência enriquecedora, permitindo não só a consolidação de conhecimentos teóricos e o desenvolvimento de competências práticas essenciais ao exercício da medicina veterinária, como também o fortalecimento da capacidade de trabalho em equipa, num contexto onde a comunicação, a cooperação entre profissionais e a partilha de responsabilidade se revelaram fundamentais para o sucesso da prática clínica quotidiana.

### **3. Estrutura do relatório**

O presente relatório encontra-se dividido em três partes principais. Na primeira parte, é apresentada a casuística observada durante o estágio curricular, com uma breve descrição dos casos acompanhados. Na segunda parte, desenvolve-se uma revisão bibliográfica sobre os sinais do trato urinário inferior em felinos (STUI) em felinos, tema escolhido pela sua elevada relevância clínica e pelo interesse pessoal demonstrado ao longo do estágio e, por fim, é apresentado e discutido um caso clínico de obstrução uretral, acompanhado pela autora, com análise crítica das decisões diagnósticas e terapêuticas adotadas.

## II. Análise da casuística observada

A primeira secção descreve de forma detalhada e sistematizada dos casos clínicos acompanhados durante o período do estágio curricular no TAH. Importa salientar que os dados aqui descritos correspondem exclusivamente à casuística observada nos turnos em que a estagiária esteve presente, não refletindo, por isso, a totalidade da casuística do hospital no mesmo período.

Para uma melhor compreensão e análise, os casos foram inicialmente distribuídos por espécie animal, e, em seguida agrupados em três áreas clínicas seguindo-se uma organização em três grandes áreas clínicas: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Medicina Preventiva. Dentro de cada áreas, procedeu-se à classificação dos casos seguindo a respetiva especialidade, conforme será descrito posteriormente.

A análise quantitativa dos dados foi realizada com recurso a gráficos e tabelas elaborados no Microsoft Excel, apresentando-se os resultados por ordem decrescente de frequência absoluta (ni) e frequência relativa (Fr).

### 1. Distribuição casuística por espécie animal e área clínica

Durante o período analisado, registaram-se um total de 597 casos clínicos, dos quais 59% correspondiam a cães e 41% a gatos (Gráfico 1).

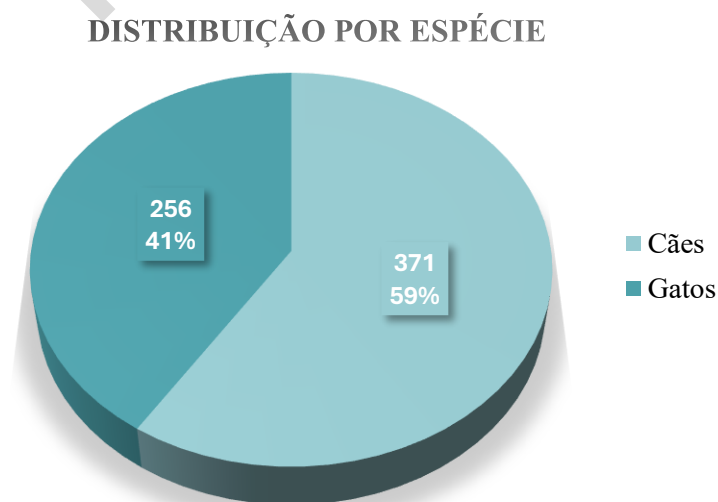


Gráfico 1 – Frequência relativa da casuística consoante a espécie

Verificou-se, assim, uma maior prevalência de casos em cães, o que pode ser justificado pelo facto de que gatos tendem a manifestar sinais clínicos mais sutis, dificultando o reconhecimento precoce das doenças pelos tutores. Outro fator importante é que na Suíça existe uma regulamentação específica para a posse de cães, exigindo visitas regulares ao médico veterinário, o que poderá contribuir para uma maior procura de serviços médicos nesta espécie.

No total, foram atendidos 355 animais (198 cães e 157 gatos) ao longo do estágio. Importa referir que alguns animais apresentaram múltiplas afeções clínicas ou foram submetidos a diferentes procedimentos numa única visita ao hospital, o que justifica o número total de casos clínicos ser superior ao número de indivíduos atendidos.

As áreas de especialidade estão representadas na Tabela 1, onde se verifica que a Clínica Médica correspondeu à maioria dos casos registados, com 430 ocorrências (Fr = 72,03%), seguida da Clínica Cirúrgica, com 126 casos (Fr = 21,10%) e, por fim, a Medicina Preventiva, responsável por 41 dos casos (Fr = 6,87%).

Tabela 1 – Distribuição da casuística pelas diferentes áreas clínicas

| Áreas clínicas             | Cães (n <sub>i</sub> ) | Gatos (n <sub>i</sub> ) | n <sub>i</sub> | Fr (%)         |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Clínica Médica</b>      | 243                    | 187                     | 430            | 72,03%         |
| <b>Clínica Cirúrgica</b>   | 88                     | 38                      | 126            | 21,10%         |
| <b>Medicina Preventiva</b> | 23                     | 18                      | 41             | 6,87%          |
| <b>Total</b>               | <b>371</b>             | <b>256</b>              | <b>627</b>     | <b>100,00%</b> |

## 2. Distribuição casuística da clínica médica

Durante o estágio, a área de Clínica Médica permitiu o acompanhamento de casos de diversas especialidades, oferecendo uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados na rotina hospitalar. Desta forma, destacou-se nesta área a importância de uma boa

anamnese e de um exame clínico detalhado, aliados aos métodos complementares apropriados para cada caso, como forma de tomar uma decisão terapêutica bem-sucedida.

A área de Clínica Médica está subdividida em 17 especialidades da medicina interna, como pode ser observado na

Tabela 2. Dentro destas, a especialidade de Gastroenterologia e Glândulas Anexas foi a mais prevalente, tendo um total de 98 casos (Fr = 21,30%). Em seguida, a área de Oftalmologia foi responsável por 41 casos (Fr = 8,91%), e Urologia e Nefrologia, com 38 casos (Fr = 8,26%). Por outro lado, a área de Hematologia e Imunoalergologia e Doenças Parasitárias apresentaram ambas apenas 11 casos (Fr = 2,17%).

Tabela 2 – Distribuição da casuística pelas diferentes áreas da clínica médica

| <b>Clínica Médica</b>                       | <b>Cães (n<sub>i</sub>)</b> | <b>Gatos (n<sub>i</sub>)</b> | <b>n<sub>i</sub></b> | <b>Fr (%)</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Gastroenterologia e Glândulas Anexas</b> | 52                          | 35                           | 87                   | 20,23%        |
| <b>Oftalmologia</b>                         | 27                          | 14                           | 41                   | 9,53%         |
| <b>Urologia e Nefrologia</b>                | 11                          | 27                           | 38                   | 8,84%         |
| <b>Urgências</b>                            | 17                          | 18                           | 35                   | 8,14%         |
| <b>Oncologia</b>                            | 18                          | 9                            | 27                   | 6,28%         |
| <b>Ortopedia e Traumatologia</b>            | 16                          | 11                           | 27                   | 6,28%         |
| <b>Estomatologia</b>                        | 15                          | 12                           | 27                   | 6,28%         |
| <b>Dermatologia</b>                         | 15                          | 11                           | 26                   | 6,05%         |
| <b>Cardiologia</b>                          | 14                          | 9                            | 23                   | 5,35%         |
| <b>Pneumologia e Otorrinolaringologia</b>   | 6                           | 10                           | 16                   | 3,72%         |
| <b>Toxicologia</b>                          | 13                          | 2                            | 15                   | 3,49%         |
| <b>Neurologia</b>                           | 9                           | 6                            | 15                   | 3,49%         |
| <b>Doença Infeciosas</b>                    | 5                           | 8                            | 13                   | 3,02%         |

|                                              |            |            |            |                |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Endocrinologia</b>                        | 4          | 7          | 11         | 2,56%          |
| <b>Hematologia e Imunoalergologia</b>        | 4          | 6          | 10         | 2,33%          |
| <b>Doenças Parasitárias</b>                  | 8          | 2          | 10         | 2,33%          |
| <b>Andrologia, Ginecologia e Obstetrícia</b> | 9          | 0          | 9          | 2,09%          |
| <b>Total</b>                                 | <b>243</b> | <b>187</b> | <b>430</b> | <b>100,00%</b> |

## 2.1. Gastroenterologia e Glândulas Anexas

A área de Gastroenterologia e Glândulas Anexas registou um total de 87 casos, conforme pode ser observado na Tabela 3. A gastroenterite idiopática foi a afeção mais prevalente, representando 29,89% dos casos. Esta elevada incidência pode ser explicada pela inespecificidade dos sinais clínicos gastrointestinais, como o vômito e a diarreia, os quais são comuns a um vasto leque de doenças. Na prática clínica, nem sempre é possível realizar investigação diagnóstica completa em todos os casos; assim, quando os exames complementares realizados não evidenciaram alterações específicas ou quando houve resposta favorável à terapêutica sintomática, os casos foram classificados como presumivelmente idiopáticos.

Outra condição de relevância foi a ingestão de corpos estranhos, observada em 18,39% dos casos. Nos cães, este diagnóstico esteve geralmente associado à sua maior propensão para a indiscrição alimentar, enquanto nos gatos a principal causa identificada foi a ingestão de bolas de pelo.

A prática clínica nesta especialidade evidenciou a importância de uma abordagem multidisciplinar, que envolva não apenas a avaliação clínica e a realização de exames complementares, mas também uma comunicação eficaz com os tutores. A adesão ao tratamento, em muitos casos, depende do esclarecimento adequado sobre a provável etiologia, a necessidade de alterações na dieta, o manejo ambiental e a monitorização contínua do estado clínico do animal.

Tabela 3 – Distribuição da casuística referente à área de Gastroenterologia e Glândulas Anexas

| <b>Gastroenterologia e Glândulas Anexas</b> | <b>Cães (n<sub>i</sub>)</b> | <b>Gatos (n<sub>i</sub>)</b> | <b>n<sub>i</sub></b> | <b>Fr (%)</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Gastroenterite idiopática</b>            | 15                          | 11                           | 26                   | 29,89%        |
| <b>Ingestão de corpo estranho</b>           | 10                          | 6                            | 16                   | 18,39%        |
| <b>Pancreatite aguda</b>                    | 5                           | 3                            | 8                    | 9,20%         |
| <b>Gastroenterite hemorrágica</b>           | 7                           | 1                            | 8                    | 9,20%         |
| <b>Fecaloma</b>                             | 2                           | 5                            | 7                    | 8,05%         |
| <b>Hepatopatia</b>                          | 2                           | 1                            | 3                    | 5,75%         |
| <b>Obstipação</b>                           | 0                           | 4                            | 4                    | 4,60%         |
| <b>Gastrite por indiscrição alimentar</b>   | 2                           | 0                            | 2                    | 2,30%         |
| <b>Colecistite</b>                          | 2                           | 0                            | 2                    | 2,30%         |
| <b>Triadite felina</b>                      | 0                           | 2                            | 2                    | 2,30%         |
| <b>Enteropatia perdedora de proteínas</b>   | 2                           | 0                            | 2                    | 2,30%         |
| <b>Shunt portossistêmico</b>                | 1                           | 0                            | 1                    | 1,15%         |
| <b>Litíase biliar</b>                       | 1                           | 0                            | 1                    | 1,15%         |
| <b>Esofagite</b>                            | 1                           | 0                            | 1                    | 1,15%         |
| <b>Megaesôfago adquirido</b>                | 1                           | 0                            | 1                    | 1,15%         |
| <b>Dilatação gástrica</b>                   | 1                           | 0                            | 1                    | 1,15%         |
| <b>Total</b>                                | <b>52</b>                   | <b>35</b>                    | <b>87</b>            | <b>100%</b>   |

## 2.2.Oftalmologia

No âmbito da especialidade de Oftalmologia, foram acompanhados 41 casos clínicos, conforme apresentado na Tabela 4. Nos cães, destacaram-se a úlcera de córnea e a

queratoconjuntivite seca como as principais afeções, representando, respetivamente, 19,51% e 17,06% dos casos. Ambas as condições têm impacto significativo na saúde ocular e no bem-estar dos animais, podendo comprometer a visão e provocar dor considerável quando não tratadas adequadamente.

Nos gatos, a afeção mais prevalente foi a uveíte, representando 9,76% dos casos. Considerando que a doença está frequentemente associada à presença de agentes infecciosos, é recomendável testar os felinos para o vírus da imunodeficiência felina e para vírus da leucemia felina (Jinks et al., 2016).

Muitas vezes, as alterações oculares podem passar despercebidas em consultas de rotina ou urgência, devido à maior atenção dirigida a outras doenças com manifestações sistémicas. Por isso, a presença de uma médica veterinária com formação em oftalmologia no TAH foi fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado destas afeções.

Tabela 4 – Distribuição da casuística referente à área de Oftalmologia

| Oftalmologia                        | Cães (n <sub>i</sub> ) | Gatos (n <sub>i</sub> ) | n <sub>i</sub> | Fr (%) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| <b>Úlcera de córnea superficial</b> | 6                      | 2                       | 8              | 19,51% |
| <b>Queratoconjuntivite seca</b>     | 6                      | 1                       | 7              | 17,06% |
| <b>Conjuntivite bacteriana</b>      | 3                      | 2                       | 5              | 12,19% |
| <b>Entrópio</b>                     | 3                      | 1                       | 4              | 9,76%  |
| <b>Uveíte bacteriana</b>            | 1                      | 3                       | 4              | 9,76%  |
| <b>Catarata</b>                     | 2                      | 0                       | 2              | 4,88%  |
| <b>Glaucoma secundário</b>          | 1                      | 1                       | 2              | 4,88%  |
| <b>Úlcera indolente</b>             | 2                      | 0                       | 2              | 4,88%  |
| <b>Luxação do cristalino</b>        | 0                      | 2                       | 2              | 4,88%  |
| <b>Descemetocèle</b>                | 1                      | 0                       | 1              | 2,44%  |
| <b>Ceratomalácia</b>                | 1                      | 0                       | 1              | 2,44%  |

|                           |           |           |           |                |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Abcesso corneal</b>    | 0         | 1         | 1         | 2,44%          |
| <b>Ceratite herpética</b> | 0         | 1         | 1         | 2,44%          |
| <b>Ceratite pigmentar</b> | 1         | 0         | 1         | 2,44%          |
| <b>Total</b>              | <b>27</b> | <b>14</b> | <b>41</b> | <b>100,00%</b> |

### 2.3.Urologia e Nefrologia

A especialidade de Urologia e Nefrologia englobou um total de 38 casos clínicos, com predominância significativa em felinos, como evidenciado na Tabela 5. A afeção mais frequentemente diagnosticada foi a doença renal crónica (DRC), correspondendo a 42,11% dos casos, o que reflete a elevada prevalência desta condição na população geriátrica felina e a sua relevância clínica no âmbito da medicina interna de animais de companhia.

A urolitíase vesical foi a segunda afeção mais observada, representando 24,12% dos casos. Os urólitos identificados incluíam cristais de estruvite, oxalato de cálcio e cistina. A cistite idiopática felina (CIF) ocupou a terceira posição em termos de frequência (13,16%).

O diagnóstico destas afeções baseou-se na realização de exames laboratoriais e imagiológicos. Entre os meios complementares de diagnóstico, o hemograma, o painel bioquímico, o ionograma, a hemogasometria e a urianálise foram utilizados com frequência. Em relação aos exames imagiológicos, a radiografia abdominal e a ecografia foram fundamentais para a avaliação das estruturas renais e vesicais.

Tabela 5 - Distribuição da casuística referente à área de Urologia e Nefrologia

| Urologia e Nefrologia       |           | Cães (n <sub>i</sub> ) | Gatos (n <sub>i</sub> ) | n <sub>i</sub> | Fr (%) |
|-----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| <b>Doença renal crónica</b> |           | 3                      | 13                      | 16             | 42,11% |
|                             | Estruvite | 1                      | 4                       | 5              | 13,16% |

|                                  |                   |           |           |           |                |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Urolitíase vesical</b>        | Oxalato de cálcio | 1         | 1         | 2         | 5,26%          |
|                                  | Cistina           | 2         | 0         | 2         | 5,26%          |
| <b>Cistite idiopática felina</b> |                   | 0         | 5         | 5         | 13,16%         |
| <b>Lesão renal aguda</b>         |                   | 2         | 2         | 4         | 10,53%         |
| <b>Infeção urinária</b>          |                   | 1         | 2         | 3         | 7,89%          |
| <b>Glomerulonefrite</b>          |                   | 1         | 0         | 1         | 2,63%          |
| <b>Total</b>                     |                   | <b>11</b> | <b>27</b> | <b>38</b> | <b>100,00%</b> |

### 2.4.Medicina de Emergência

Conforme apresentado na Tabela 6, foram acompanhados 35 casos na área de Medicina de Emergência. As obstruções uretrais foram as situações mais frequentes durante o período, sobretudo em gatos machos com 37,14% dos casos. Em seguida, a presença de hemoabdômen foi o segundo caso mais comum (14,29%), verificado exclusivamente em cães, sendo maioritariamente associada a traumatismos ou à rutura de massas esplênicas com origem neoplásica.

A atuação nesta área exigiu decisões clínicas rápidas e fundamentadas, proporcionando uma experiência de aprendizagem prática. A ultrassonografia foi uma ferramenta essencial na avaliação de pacientes críticos, sendo frequentemente aplicados os protocolos Avaliação Ecográfica com Foco no Trauma Abdominal (A-FAST<sup>1</sup>) e Avaliação Ecográfica com Foco no Trauma Torácico (T-FAST<sup>2</sup>), que permitiram identificar alterações e orientar a conduta terapêutica de forma eficiente.

Tabela 6 - Distribuição da casuística referente à área de Medicina de Emergência

| Urgências | Cães (n <sub>i</sub> ) | Gatos (n <sub>i</sub> ) | n <sub>i</sub> | Fr (%) |
|-----------|------------------------|-------------------------|----------------|--------|
|-----------|------------------------|-------------------------|----------------|--------|

<sup>1</sup> Do termo em inglês “Abdominal Focused Assesment with Sonography for Trauma”  
<sup>2</sup> Do termo em inglês “Thoracic Focused Assesment with Sonography for Trauma”